

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 12

Luxación Congénita de cadera

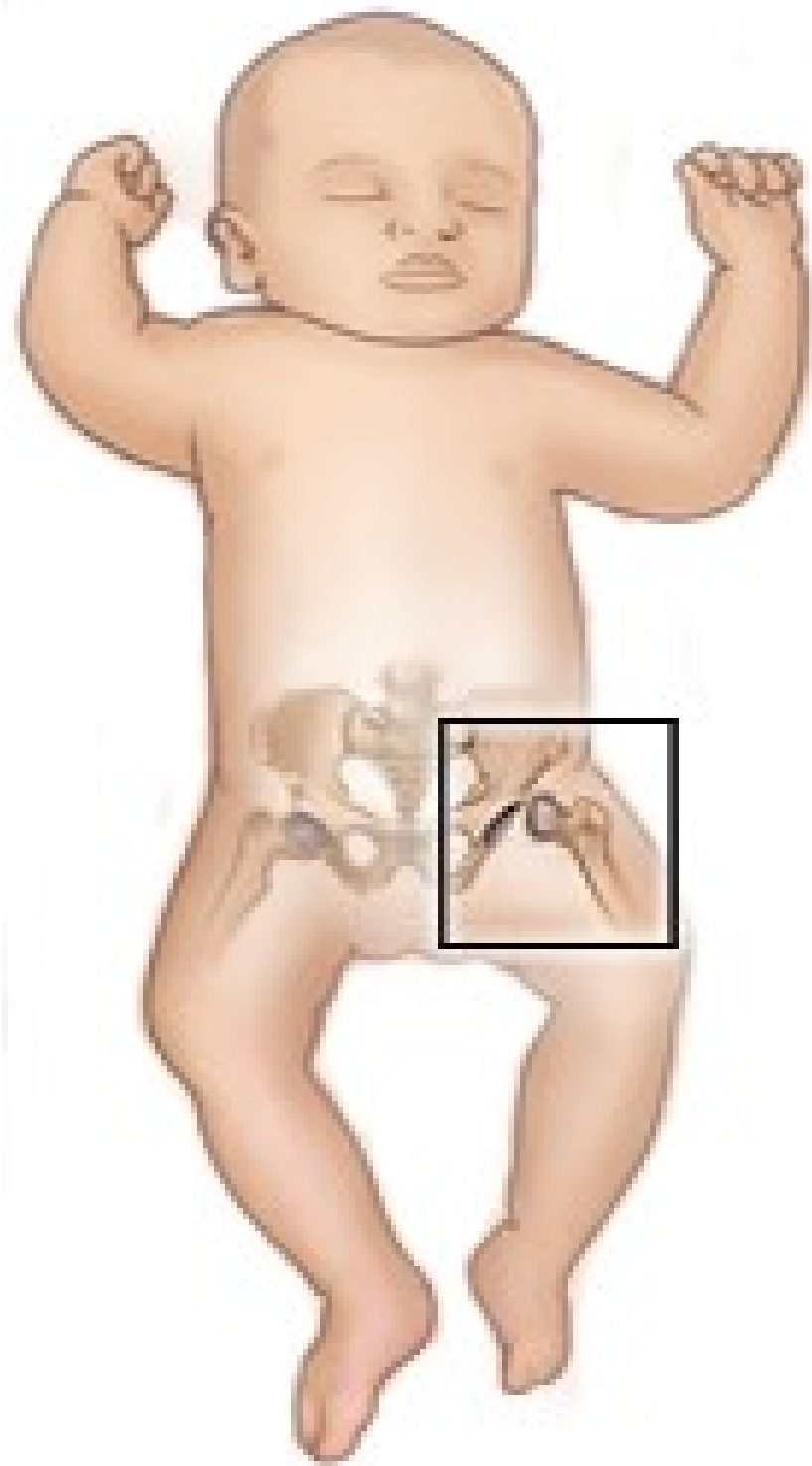
Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio

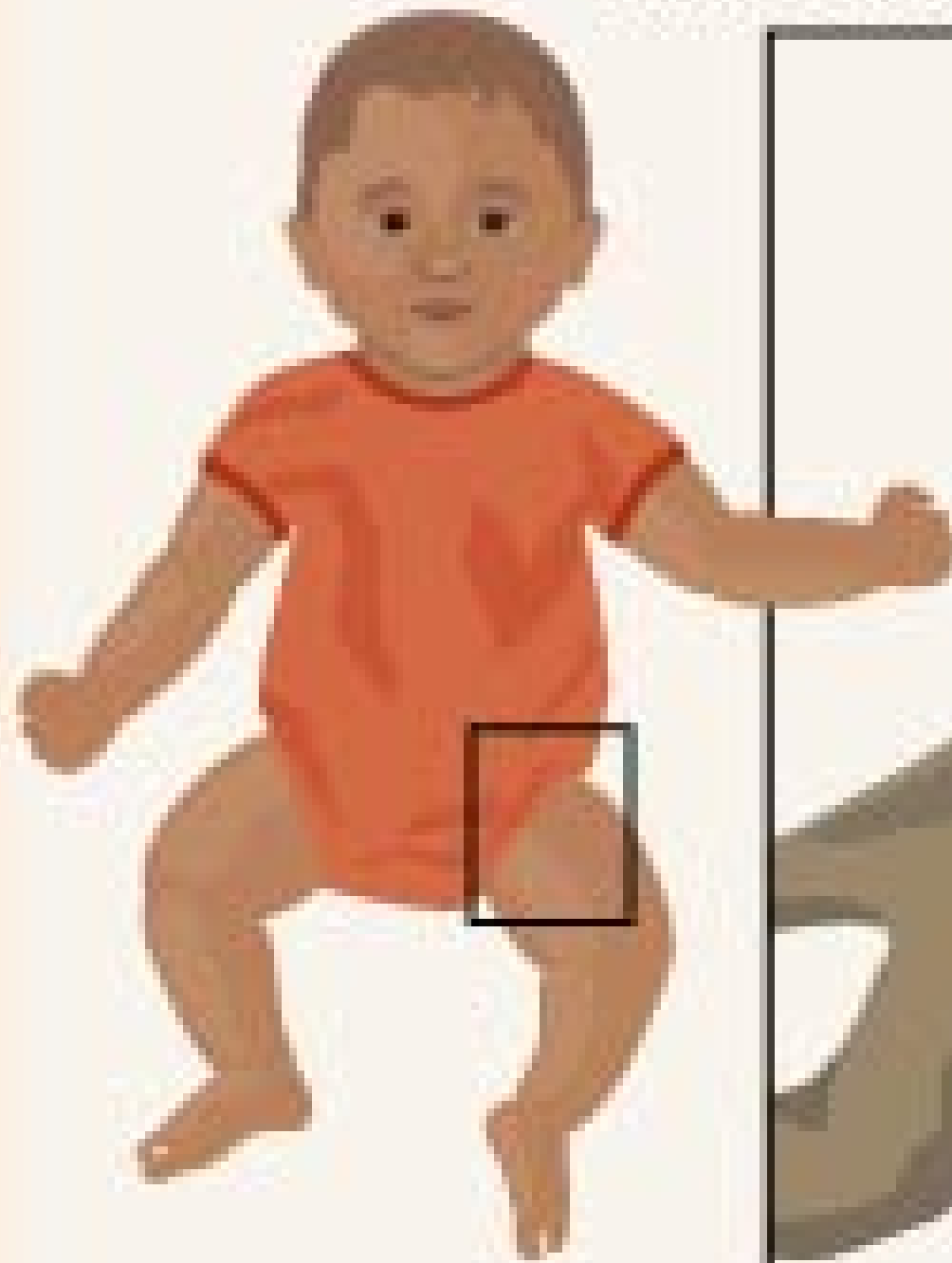
TEMARIO

- Etiopatogenia
- Tratamiento Ortopédico
- Tratamiento Quirúrgico
- Tratamiento Rehabilitador





Articulación normal de la cadera



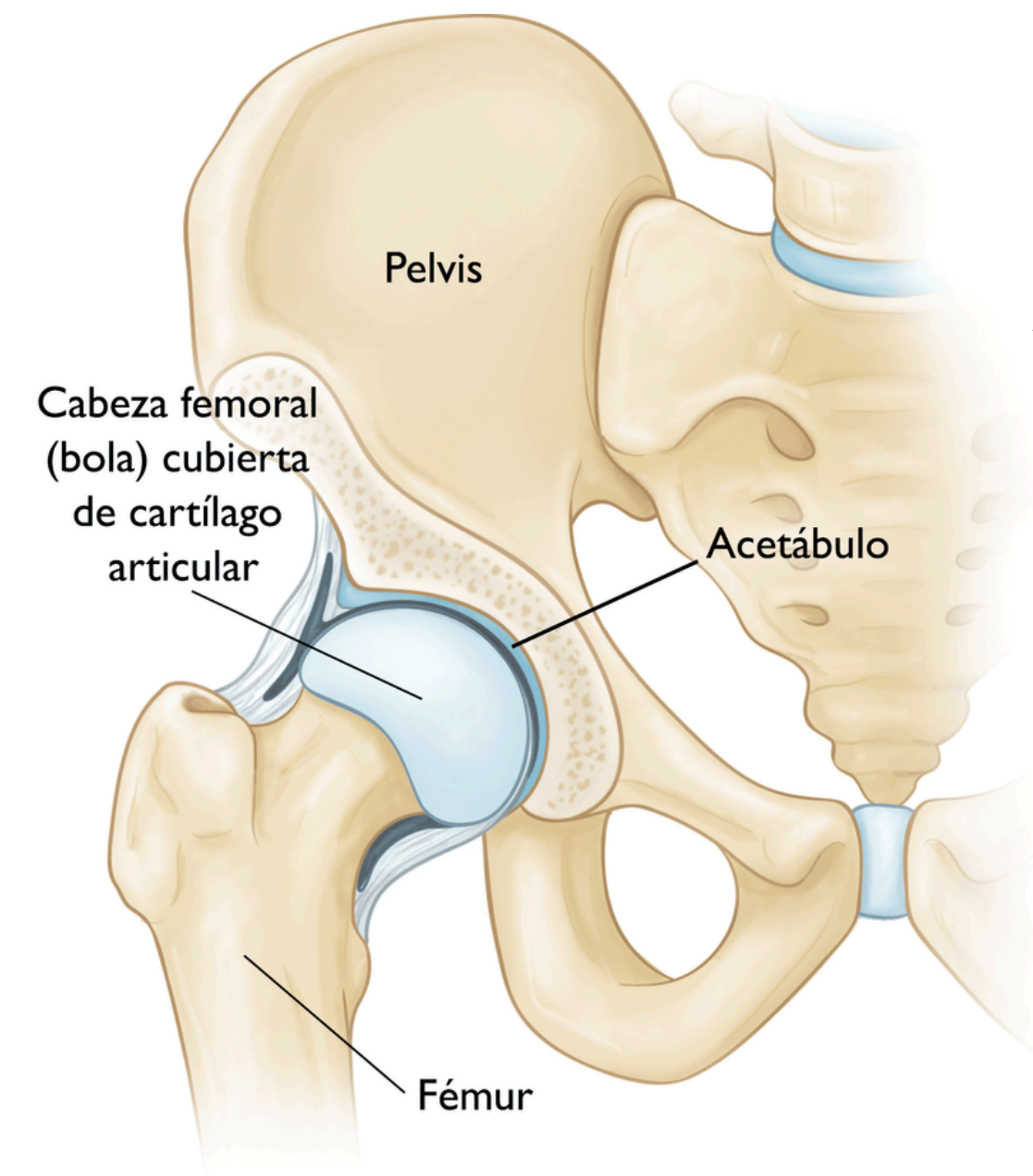
Displasia evolutiva

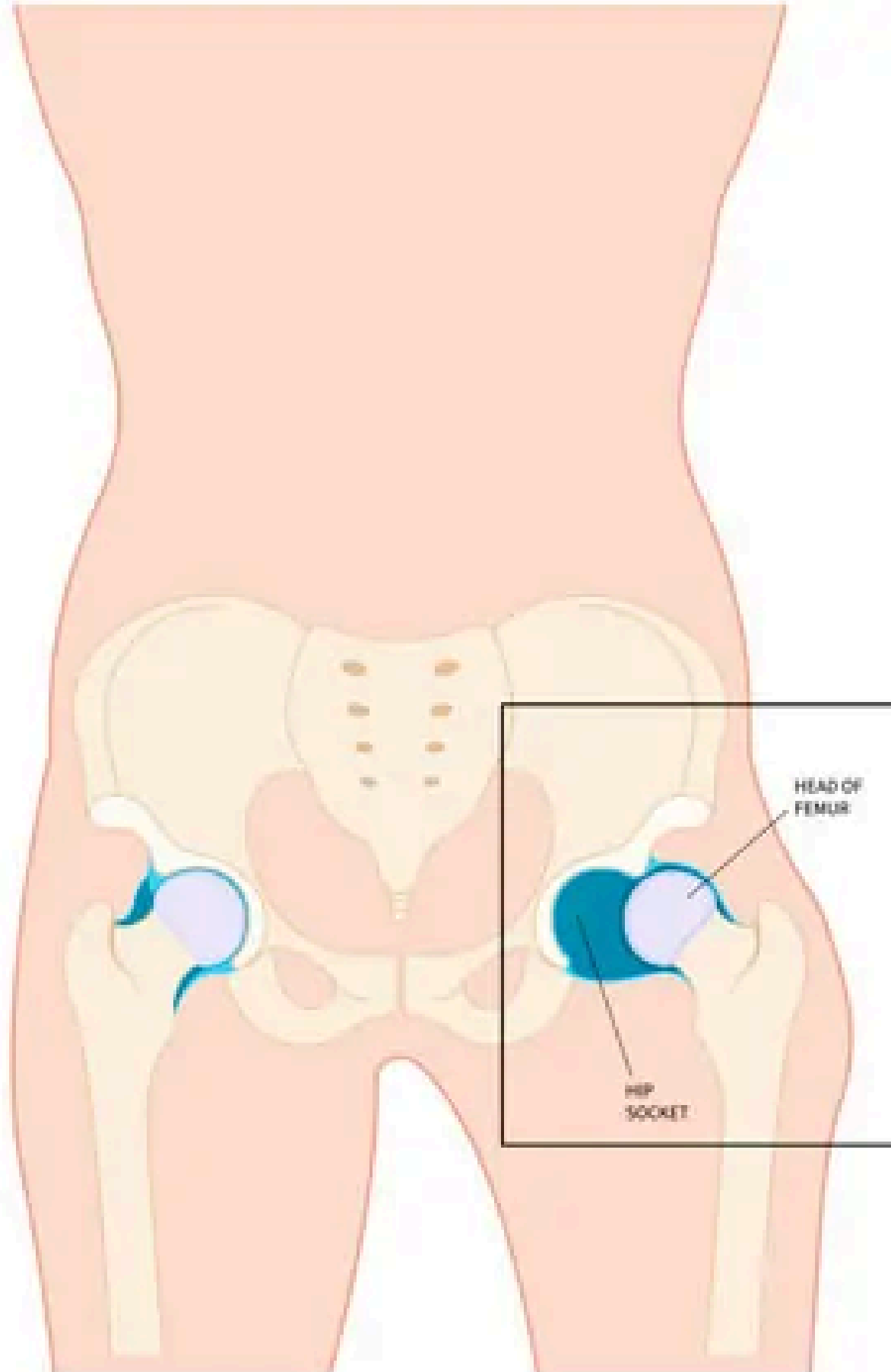


Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC), es una anomalía presente al nacer donde la cabeza del fémur no encaja correctamente en el acetábulo (cavidad pélvica).

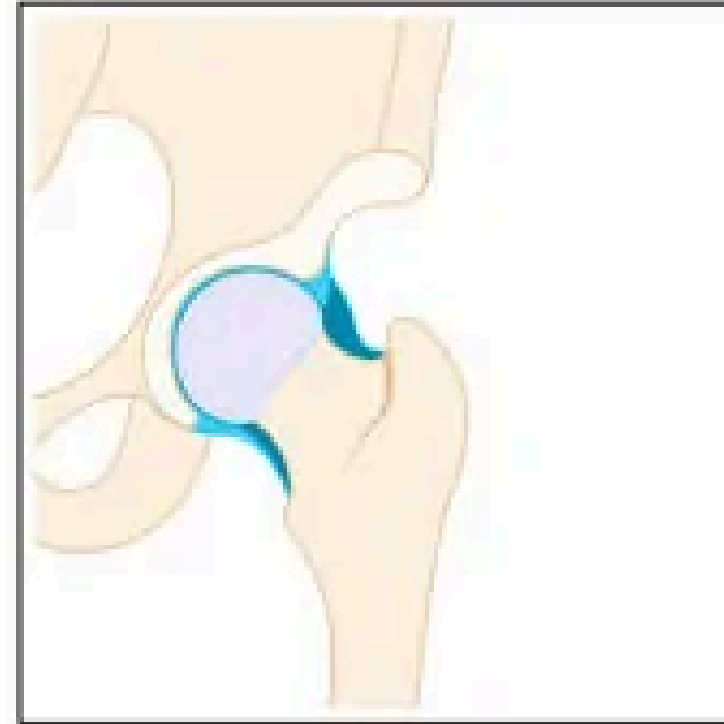
El acetábulo o parte cóncava de la cadera no cubre completamente la cabeza o parte redonda del extremo superior del fémur. Esto hace que la articulación de la cadera se disloque total o parcialmente.

Se refiere a una **condición ortopédica** en la que el acetábulo, o techo de la cadera, está fuera de lugar en diversos grados.

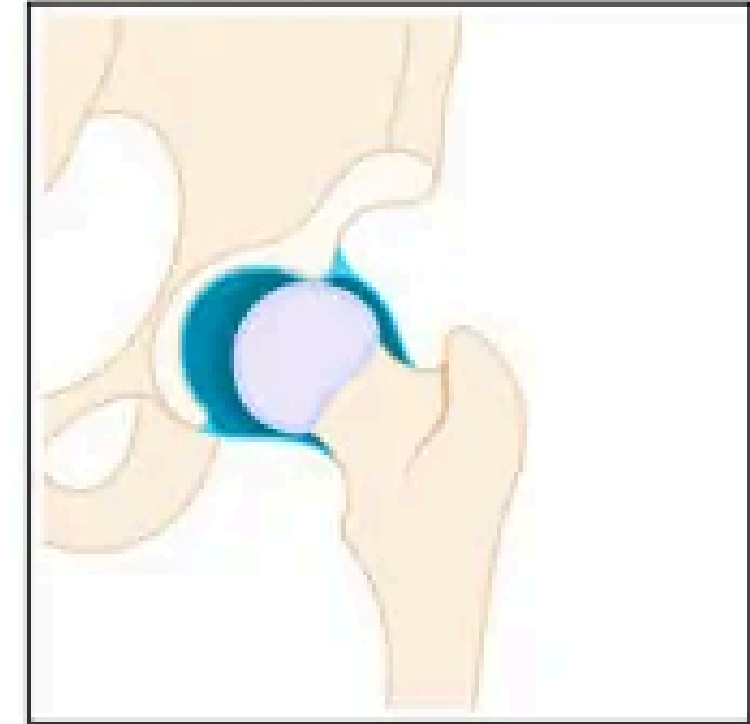




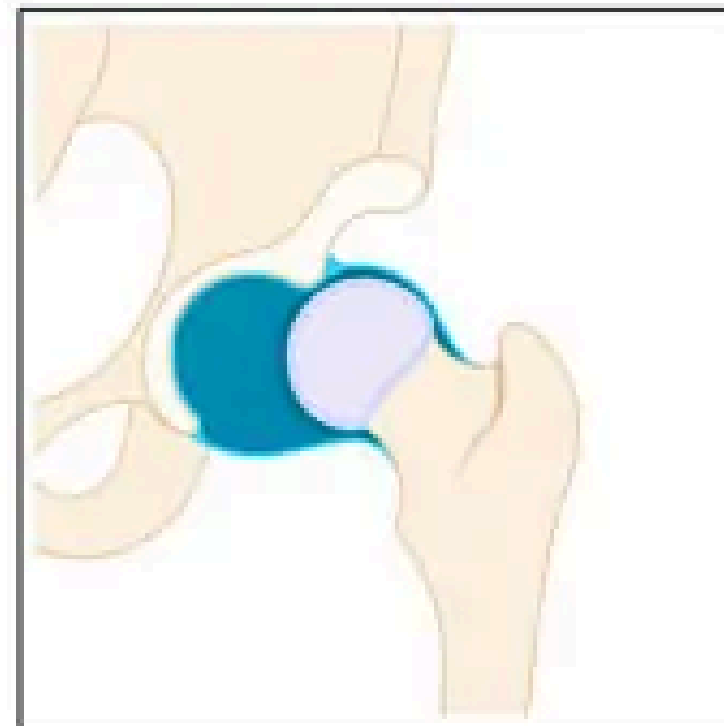
DISLOCATED HIP



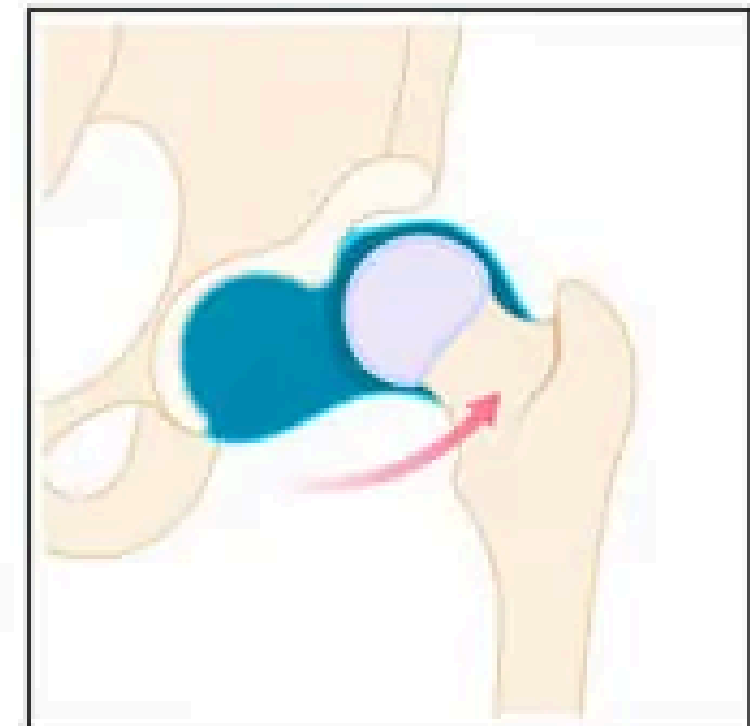
NORMAL



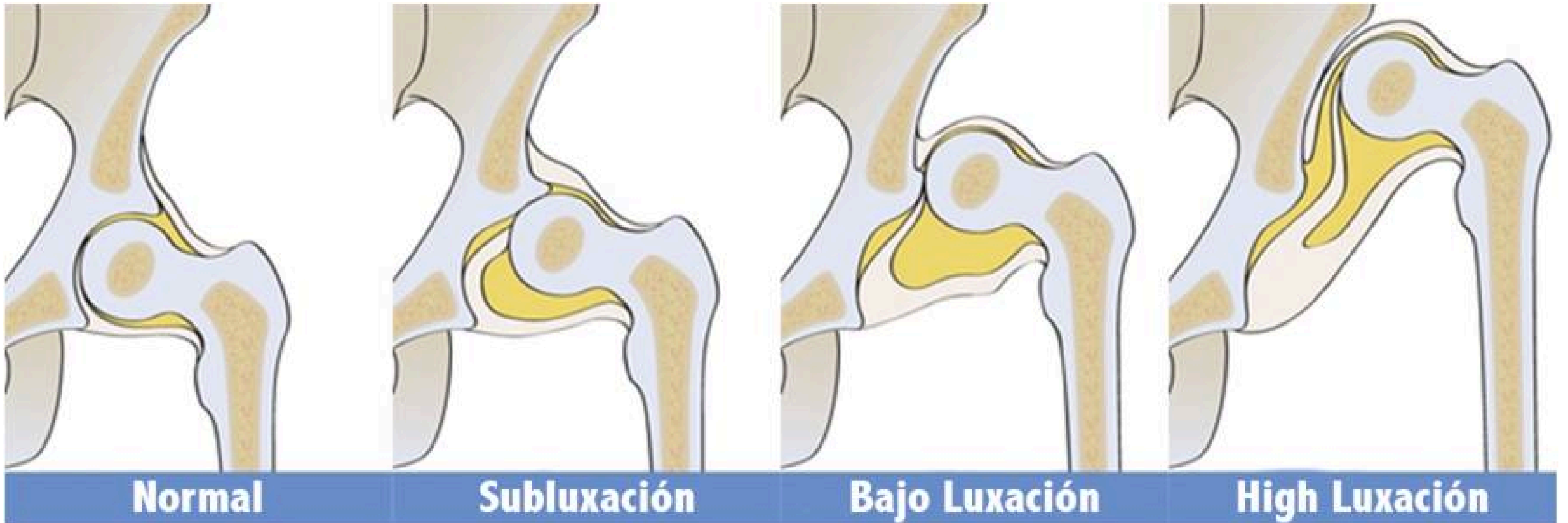
SUBLUXATION



LOW DISLOCATION



HIGH DISLOCATION



ETIOPATOGENIA

La displasia de cadera se debe a una combinación de factores genéticos y mecánicos que impiden que la articulación se desarrolle correctamente.

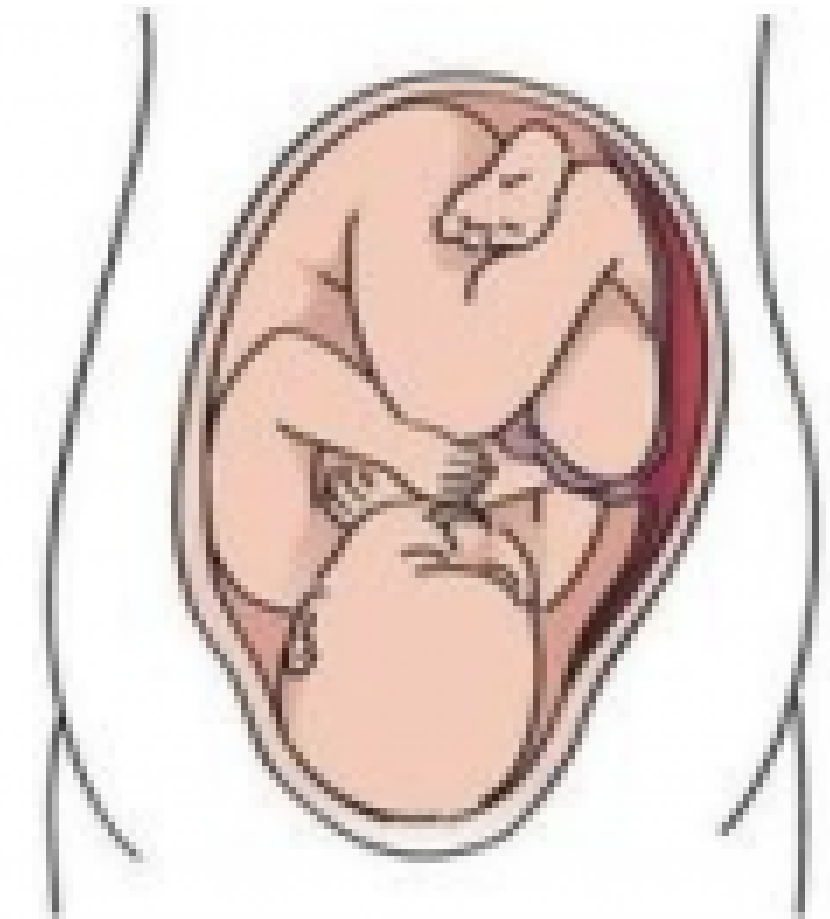
Factores genéticos/hereditarios:

- Historial familiar de displasia de cadera.
- Más común en mujeres.



Factores mecánicos y del embarazo:

- Presentación podálica: Bebé en posición de nalgas.
- Oligohidramnios: Poco líquido amniótico.
- Primer embarazo: Menos espacio en el útero.
- Arropamiento apretado: Mantener las piernas del bebé juntas y estiradas.
- Gran peso al nacer.



Posición normal.



Posición de nalgas.

SIGNOS/SÍNTOMAS



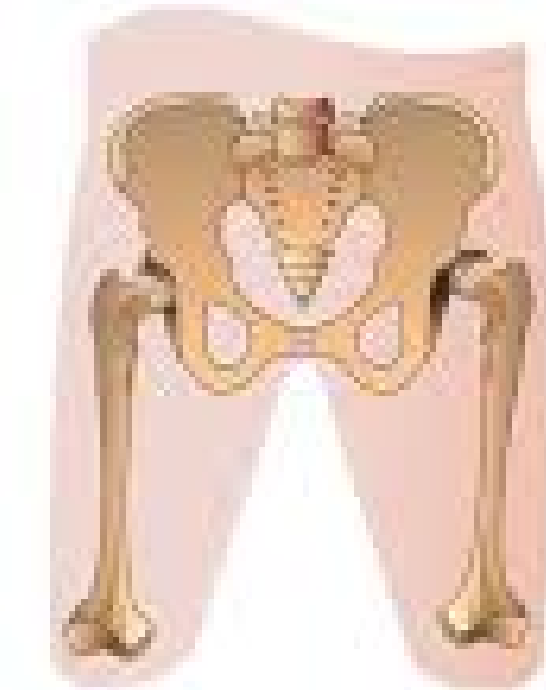
En bebés y niños pequeños

- Asimetría de pliegues: Pliegues desiguales en los muslos o glúteos.
- Piernas de diferente longitud: Una pierna puede parecer más corta.

SIGNOS/SÍNTOMAS



- Movilidad reducida: Dificultad para separar las piernas al cambiar pañales o menor movimiento en un lado.
- Signos de Ortolani/Barlow: Un "clic" al abducir y aducir la cadera (puede desaparecer pronto).
- Cojera: Al empezar a caminar, se nota una cojera en el lado afectado.



Normal

Subluxación



Normal

Dislocado

TRATAMIENTO ORTOPÉDICO

Si la displasia de cadera se detecta antes de los 6 meses de edad, es posible proceder a un tratamiento conservador que no requiere cirugía.

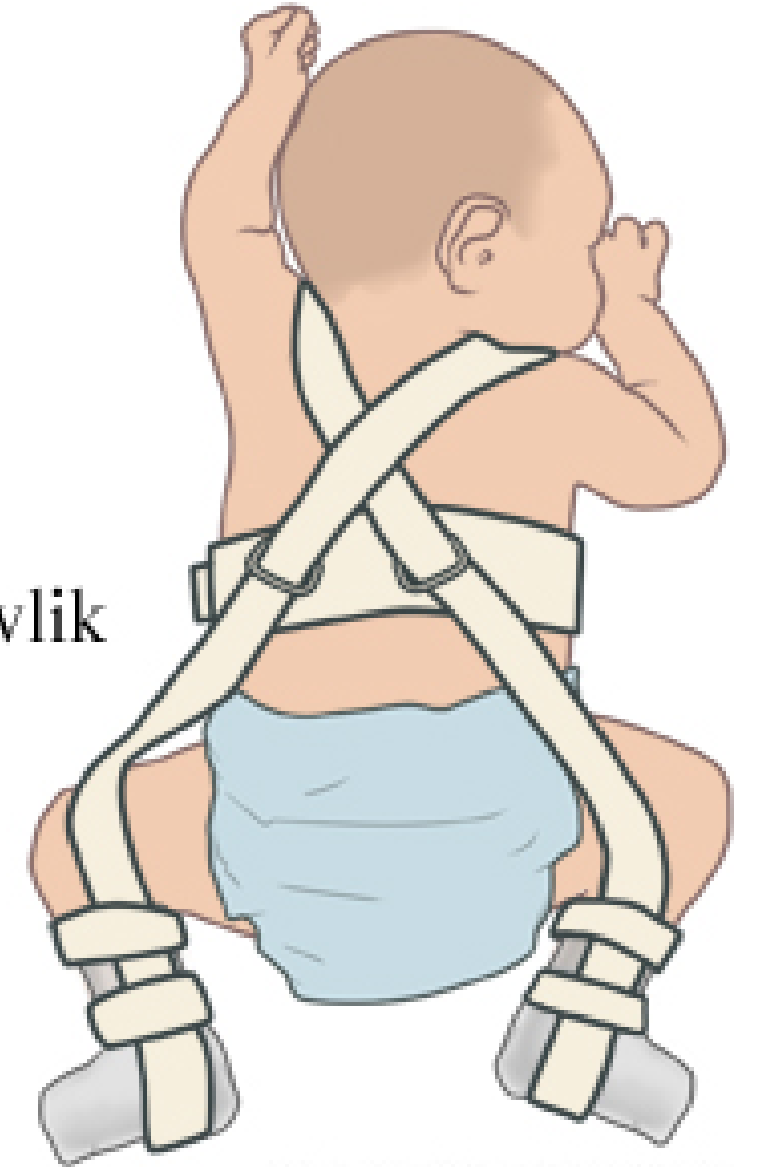
Actualmente, el tratamiento más utilizado es el arnés de Pavlik, que ayuda a mantener las piernas de los niños abiertas, lo que a su vez ayuda a que la cavidad de la cadera entre en su lugar.







Arnés de Pavlik



© Healthwise, Incorporated

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El tratamiento quirúrgico de la displasia de cadera en niños busca estabilizar la articulación cuando los métodos no quirúrgicos fallan o el diagnóstico es tardío, especialmente tras los 6-18 meses

Reducción Cerrada (6-24 meses): Procedimiento menos invasivo bajo anestesia para reposicionar la cabeza femoral, seguido de un yeso en espiga durante meses.

Reducción Abierta: Se utiliza cuando el tejido (tejido blando, cápsula) impide que la cadera entre en su lugar. Se realiza una incisión en la ingle para extraer tejido y reposicionar el fémur.

Osteotomías: (Pélvica/Femoral): Se corta y reposiciona el hueso (fémur o pelvis) para mejorar la profundidad y estabilidad de la cavidad (acetábulo) en niños mayores o casos complejos.



⚡ Tratamiento de la displasia de cadera: osteotomía periacetabular

From a healthcare provider in Spain >

Copy link

¿QUÉ ES UNA
**OSTEOTOMÍA
PERIACETABULAR?**

Watch on  YouTube



TRATAMIENTO
REHABILITADOR

**Actividad
sincrónica**

Muchas gracias

Presente.